PENGARUH PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

SKRIPSI

OLEH

INTAN WULANTARI
NPM : 21.22.048

PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KEBIDANAN INSTITUT KESEHATAN
DELI HUSADA DELI TUA
TAHUN 2025

PENGARUH PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Kebidanan
Deli Husada Deli Tua

OLEH

INTAN WULANTARI
NPM : 21.22.048

PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KEBIDANAN INSTITUT KESEHATAN
DELI HUSADA DELI TUA
TAHUN 2025

LEMBAR PANITIA PENGUJI

Telah Diuji

Tanggal :

PANITIA PENGUJI SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI

Penguji I: NS Dewi Tiansa Barus S.kep.MKM

NPP: 199410212013121001

Penguji II : Bd. Peny Ariani, SST. M.Keb

NPP: 19890614.201008.2.001

Penguji III : Bd. Stefany Anastasia S, SST.,M.Tr.Keb

NPP: 19910527.201008.2.001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh:

INTAN WULANTARI

NPM : 21.22.048

Telah diuji dan dipertahankan didepan TIM penguji Sidang Hasil Kebidanan Program Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Tim Penguji I

NS Dewi Tiansa Barus S.kep.MKM

NPP: 19941021.201312.1.001

Tim Penguji II

Tim Penguji III

Bd. Peny Ariani, SST. M.Keb

NPP: 19890614.201008.2.001

Bd. Stefany Anastasia S, SST.,M.Tr.Keb

NPP: 19910527.201008.2.001

Diketahui,

Ketua Jurusan Program Sarjana Kebidanan

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Bd. Putri Ayu Yessy Ariescha SST, M.keb

NPP. 19900326.201008.2.001

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL

Judul	: Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025
Nama	: Intan Wulantari
Npm	: 21.22.048
Jenjang	: Sarjana Kebidanan
Program Study	: Kebidanan

Pembimbing

NS Dewi Tiansa Barus S.kep.MKM

NPP: 19941021.201312.1.001

Mengetahui,

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Fakultas Kebidanan

Dekan

Bd. Peny Ariani, SST. M.Keb

NPP: 19890614.201008.2.001

Tanggal Seminar Proposal : 27 Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL

Judul	: Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025
Nama	: Intan Wulantari
Npm	: 21.22.048
Jenjang	: Sarjana Kebidanan
Program Study	: Kebidanan

Pembimbing

NS Dewi Tiansa Barus S.kep.MKM

NPP: 19941021.201312.1.001

Mengetahui,

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Fakultas Kebidanan

Dekan

Bd. Peny Ariani, SST. M.Keb

NPP: 19890614.201008.2.001

Tanggal Seminar Skripsi :

PERYATAAN

PENGARUH PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Deli Tua, 1 Juni 2025

Intan Wulandari

Npm : 21.22.048

(VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

Intan Wulantari
Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kebidanan

ABSTRAK

Masalah stunting pada anak usia dini merupakan isu kesehatan masyarakat yang berkaitan erat dengan asupan gizi, salah satunya konsumsi sayur yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting usia 3 tahun. Subjek penelitian adalah anak-anak usia 3 tahun yang mengalami stunting dan terdaftar di Klinik Sumiariani, dengan jumlah sampel sebanyak 30 anak yang dipilih secara purposive. Intervensi VEM diberikan selama 8 hari melalui pendekatan visual, sensorik, dan edukatif yang disesuaikan dengan usia anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain *One Group Pre Test and Post Test Design*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menilai satu kelompok, dengan uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam perilaku makan sayur setelah intervensi ($p < 0,01$), yang ditunjukkan melalui peningkatan frekuensi dan jumlah konsumsi sayur. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan VEM efektif dalam meningkatkan perilaku makan sayur pada anak stunting usia 3 tahun.

Kata Kunci: stunting, perilaku makan sayur, anak usia dini, Vegetable Eating Motivation (VEM), intervensi gizi

PENGARUH PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

Intan Wulantari
Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kebidanan

ABSTRACT

Title: *The Effect of Vegetable Eating Motivation (VEM) Implementation on Vegetable Consumption Behavior in Stunted Children Aged 3 Years*

The problem of stunting in early childhood is a public health issue that is closely related to nutritional intake, one of which is low vegetable consumption. This study aims to determine the effect of implementing the Vegetable Eating Motivation (VEM) approach on vegetable eating behavior in stunted children aged 3 years. The subjects of the study were 3-year-old children who experienced stunting and were registered at the Sumiariani Clinic, with a sample size of 30 children selected purposively. The VEM intervention was given for 8 days through a visual, sensory, and educational approach that was adjusted to the child's age. This study was conducted using the One Group Pre Test and Post Test Design, which is a study conducted to assess one group, with the Wilcoxon test. The results showed a significant increase in vegetable eating behavior after the intervention ($p < 0.01$), which was indicated by an increase in the frequency and amount of vegetable consumption. These findings indicate that the VEM approach is effective in improving vegetable eating behavior in stunted children aged 3 years.

Keywords: stunting, vegetable consumption behavior, early childhood, Vegetable Eating Motivation (VEM), nutrition intervention

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta karunia-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025".**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program studi sarjana kebidanan Deli Husada Deli Tua, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skirpsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan proposal ini.

Untuk itu peneliti dengan kerendahan hati memohon agar para pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Peneliti dalam melakukan skripsi ini banyak dapat mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Terulin S. Meliala, AM.Keb, SKM, M.Kes selaku ketua Yayasan RSU SEMBIRING Delitua yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi S1 Kebidanan Deli Husada Deli Tua.
2. Drs. Johannes Sembiring, M.Pd, M.Kes selaku Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Bd. Peny Ariani, SST,. M.Keb, Selaku Dekan Prodi Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

4. Bd. Kristin Natalia SST ,M.Kes selaku Wali Tingkat Program studi S1 Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skirpsi ini.
5. NS Dewi Tiansa Barus S.kep.MKM, selaku dosen pembimbing saya dalam menyelesaikan proposal ini yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta memberikan petunjuk, arahan, semangat dan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skirpsi ini.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu Staff Dosen Program Studi sarjana kebidanan yang telah memberikan begitu banyak pengetahuan selama peneliti menjalankan proses perkuliahan.
7. Terkhusus dan teristimewa peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda (Suparman) dan ibunda (Sri Mulyati) tercinta Skripsi ini peneliti persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia peneliti dengan begitu banyak kebahagiaan untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada peneliti. Terima kasih juga telah menjadi orang tua yang sempurna, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan S1 Kebidanan di Deli Husada Deli Tua dan peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Abang Anggie pranata dan adek geysha Adelia Putri peneliti, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada Darma putra Wijaya peneliti ucapkan terima kasih karena telah begitu baik memberikan dukungan, kebaikan, perhatian, kebijaksanaan dan simpatik

kepada peneliti sehingga peneliti bersemangat menjalani pendidikan disini dan bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua.

Deli Tua, , 1 Juni 2025 2025

Peneliti,

Intan Wulantari

Npm :21.22.048

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Indentitas Pribadi

Nama	:	Intan Wulantari
Tempat/Tgl. Lahir	:	Durian puloan 09 april 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Anak Ke	:	Ke-2 Dari 6 Bersaudara
Agama	:	Islam

B. Data Orang Tua

Nama Ayah	:	Suparman
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Nama Ibu	:	Sri mulyati
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Agama	:	Islam
Alamat	:	Durian puloan

C. Riwayat Pendidikan

Tahun 2009-2015	:	SD Negri sarang Ginting
Tahun 2015-2018		MTs Negri sarang Ginting
Tahun 2018-2021		MAN Negri sarang Ginting
Tahun 2021-2025		Sedang Mengikuti Program Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **14**

1.1. Latar belakang 14

1.2. Rumusan masalah 7

1.3. Tujuan penelitian 7

1.3.1. Tujuan umum 7

1.3.2. Tujuan khusus 7

1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

2.1. Stunting 9

2.1. 1. Pengertian Stunting 9

2.2. Penyebab Stunting 12

2.3. Faktor – faktor penyebab stunting 15

2.4. Gejala Stunting 15

2.5. Cara meningkatkan konsumsi makan sayur pada anak 17

2.6. Menu makanan yang bergizi untuk mencegah stunting pada anak 19

2.7. Vegetable Eating Motivation (VEM) 23

2.7.1. Pengertian Vegetabel Eating Motivation (VEM) 23

2.8. Kerangka teori 28
2.9. Kerangka konsep 29
2.9.1. Hipotesis 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1. Jenis dan Desain Penelitian 31
3.2. Waktu dan lokasi penelitian 31
3.2.1. Waktu penelitian 31
3.2.2. Lokasi penelitian 32
3.3. Populasi dan sampel 32
3.3.1. Populasi 32
3.3.2. Sampel 32
3.4. Variabel dan definis operasional 32
3.4.1. Variabel 32
3.4.2. Defenisi operasional 33
3.5. Etika penelitian 34
3.5.1. Lembar persetjuan (informen concent) 35
3.5.2. Tanpa nama (anominity) 35
3.5.3. Kerahasian (confidenciality) 35
3.6. Prosedur penelitian 36
3.6.1. Persiapan 36
3.6.2. Pengumpulan data 36
3.7. Analisis data 36
2.7.1. Analisis univariat 36
3.7.2. Analisis Bivariat 37
BAB IV HASIL PENELITIAN 38
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 38

4.2 Karakteristik Responden 38
4.3. Analisis Data 39
4.3.1. Hasil Analisis Univariat 39
4.3.2. Hasil Analisis Bivariat 40
BAB V PEMBAHASAN 42
5.1 Analisis Univariat 42
5.1.1 Responden Responden *pre-test* dan *post test* Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun 42
5.2. Analisis Bivariat 43
5.2.1 Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun 43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 46
6.1. Kesimpulan 46
6.2.1. Bagi responden 46
6.2.2. Bagi Institusi Pendidikan 47
6.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 47
DAFTAR PUSTAKA 48
DAFTAR LAMPIRAN 50
LEMBAR PERSETUJUAN (*INFORMED CONCENT)* BERSEDIA 52
BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN 52
LEMBAR OBSERVASI 53
LEMBAR KOSIONER 53
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 55
SURAT PENELITIAN 62

DOKUMENTASI PENELITIAN 63
UJI STATISTIK PENELITIAN 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kacang-Kacangan 20
Gambar 2. 2. Daging Ayam 20
Gambar 2. 3. Telur 21
Gambar 2. 4. Ikan 21
Gambar 2. 5. Tempe Dan Tahu 22
Gambar 2. 6. Hati Ayam 22
Gambar 2. 7. Buah Beri 23
Gambar 2. 8. Sayuran 23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kerangka kosep 29

Tabel 3. 1. Variabel dan Definisi Operasional 33

Tabel 4. 1. Distribusi Karakteristik Responden Pengaruh penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun 38

Tabel 4. 2. Distribusi Responden *pre-test* dan *post test* frekuensi makan sayur pada anak stunting usia 3 tahun dengan terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun..... 39

Tabel 4. 3. Uji wilcoxon Pengaruh penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun tahun 2025 40

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	:	Permohonan Menjadi Responden
Lampiran 2	:	Lembar Persetujuan (*Informed Concent*) Bersedia Berpartisipasi Sebagai Responden
Lampiran 3		Lembar Observasi Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025 Tahun
Lampiran 4	:	Lembar Kuesioner
Lampiran 5	:	Standar Operasional Prosedur Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025
Lampiran 6	:	Master Data Penelitian
Lampiran 7	:	Surat Izin Penelitian
Lampiran 8		Dokumentasi Penelitian
Lampiran 9		Uji Statistik Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak dianggap terhambat pertumbuhannya jika tinggi badannya terhadap usia lebih dari dua standar deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak menurut WHO. Pertumbuhan terhambat di awal kehidupan -- terutama dalam 1000 hari pertama sejak pembuahan hingga usia dua tahun - pertumbuhan yang terganggu memiliki konsekuensi fungsional yang merugikan pada anak. (World Health Organization, 2015)

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Menurut survei kesehatan inodnesia (SKI) 2023, prevelensi stunting nasional sebesar 21,5% turun menjadi 0,8% bila di bandingkan tahun sebelumnya. Menurut juru bicara (kemenkes) M. Syahrir mengatakan untuk mencapai target, pemerintah telah melakukan dua intervensi, yakni intervensi gizi spresifik dan intervensi sensitif. Intervensi gizi spesifik berpokus pada penanganan penyebab langsung stunting, seperti kekurangan asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar pada keluarga dan masyarakt karena berkaitan dengan penyediaan air bersih dan peningkatan akses pangan (Rokom, 2024). Pemprov sumut berhasil menurunkan prevelensi stunting 2,2% di tahun 2023 menjadi 18,9% dengan berbagai intervensi yang dilakukan

(Pemprofsumut,2024. . Prevenlensi stanting di indonesia masi jauh dari target penurunan sebesar 14% pada tahun 2024.

Menurut badan kesehatan dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gr per orang perhari, yang terdiri dari 250 gr sayur (setara dengan 2 ½ porsi atau 2 ½ gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan) dan 150 g buah, (setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1 ½ potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang). Bagi orang Indonesia dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gr perorang perhari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400-600 gr perorang perhari bagi remaja dan orang dewasa. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur (Kalmpourtzidou et al., 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2017). Kurangnya konsumsi sayur dan buah pada anak usia prasekolah dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes, penyakit mata, anemia, obesitas, dan penyakit lain seperti sembelit. (Wulansari & Chandra, 2019)

Permasalahan stunting merupakan isu baru yang berdampak buruk terhadap permasalahan gizi di Indonesia karena mempengaruhi fisik dan fungsional dari tubuh anak serta meningkatnya angka kesakitan anak, bahkan kejadian stunting tersebut telah menjadi sorotan WHO untuk segera dituntaskan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017, angkanya mencapai 36,4%. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi

stunting sebesar 30,8%. Dibandingkan dengan hasil SSGBI angka stunting berhasil ditekan 3,1% dalam setahun terakhir. Menkes berharap angka stunting dapat terus turun 3 persen setiap tahun, sehingga target 19% pada tahun 2024 dapat tercapai.

Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi teratas dengan prevalensi balita stunting sebesar 35,3% walaupun angka tersebut menurun dari 2021 yang sebesar 37,8%. Sulawesi Barat menempati posisi kedua dengan prevalensi balita stunting sebesar 35%, disusul Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat dengan prevalensi balita stunting masing-masing sebesar 34,6% dan 32,7%. Terdapat 18 provinsi dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka nasional, dan 16 provinsi berada di bawah rata-rata angka stunting nasional. Bali menempati peringkat terbawah alias prevalensi balita stunting terendah nasional. Persentasenya hanya 8% atau jauh di bawah angka stunting nasional pada 2022. Angka Stunting Indonesia Turun pada 2022.

Kondisi kesehatan seseorang dapat digambarkan melalui status gizi yang dimiliki. Status gizi digunakan untuk menilai keseimbangan gizi dalam tubuh, apakah dapat menunjang kehidupan, mempertahankan fungsi tubuh normal ataupun menghasilkan energi untuk mempertahankan kondisi kesehatan sesorang. Status gizi dapat dipengaruhi oleh kualitas konsumsi gizi seseorang. Status gizi yang baik diperoleh apabila tubuh menerima zat gizi yang cukup atau sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan secara efektif (Armin et al., 2024).

Menurut Laporan Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 terdapat 96,7% penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 5 tahun

dinyatakan kurang dari 5 porsi per hari konsumsi sayur dan buah dalam seminggu(Survei Kesehatan Indonesia, 2023),Kelompok usia 5-9 tahun merupakan kelompok usia yang memiliki presentase proporsi tidak konsumsi sayur dan buah tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya yakni di angka 18,5%(Survei Kesehatan Indonesia, 2023).

Salah satu penyebab rendahnya konsumsi sayur pada anak karena kurangnya pengetahuan dan sikap mengabaikan pentingnya makan sayur (Islaeli et al., 2020). Pengabaian terhadap pentingnya makan sayur dapat terjadi karena faktor eksternal dan internal anak. Faktor eksternal anak misalnya berasal dari orang tua atau lingkungan yang kurang mengenalkan dan menanamkan pentingnya makan sayur pada anak. Sedangkan, faktor internal anak, misalnya anak yang mengalami food neophobia dan pilih-pilih makan. Food neophobia adalah ketidakinginan anak untuk mengonsumsi makanan yang baru sedangkan pilih-pilih makanan adalah ketidakinginan mengonsumsi makanan tertentu walaupun pernah mencobanya (Herawati et al., 2021)

Anak yang menderita kekurangan gizi mengalami penurunan kemampuan menggenggam, berkurangnya konsentrasi belajar, pertumbuhanfisik yang kurang optimal, gangguan pertahanan tubuh, gangguan struktur dan fungsi otak, serta gangguan perilaku (Helmawati & Fitriana, 2018; Prastina, 2020).

Sayur merupakan makanan yang jarang disukai oleh anak-anak. Beberapa anak tidak suka mengkonsumsi sayur disebabkan karena sayur memiliki rasa yang pahit, warnanya yang tidak menaikan selera makan anak dan cara

mengolah sayur yang kadang kurang higienis sehingga membuat sayur-sayuran kurang di konsumsi anak-anak usia prasekolah (Ramdhaniet al., 2023; R. Rostinah & Nelly, 2022).

Hasil survei oleh WHO menunjukan bahwa wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Sri Langka, dan Thailand, memiliki konsumsi buah dan sayur terendah dengan jumlah konsumsi buah dan sayur harian anak usia 5-14 tahun hanya 198 gram pada anak laki-laki dan 183 gram pada anak perempuan. Berdasarkan studi tentang konsumsi sayuran pada anak usia 2-5 tahun menunjukkan bahwa anak usia prasekolah mengkonsumsi 25% sayuran dari jumlah yang direkomendasikan (Dennison, 2019).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur (setara dengan 2 ½ porsi atau 2 ½ gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan) dan 150 gram buah, (setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1 ½ potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang). Bagi masyarakat Indonesia terutama balita dan anak usia sekolah dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram per orang per hari dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400-600 gram per orang per hari. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari sebenarnya kita perlu mengikuti Pedoman Gizi Seimbang sesuai Permenkes No. 41 Tahun 2014. “Sebanyak 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap hari atau setengah bagian piring berisi buah dan sayur (lebih banyak sayuran) setiap kali makan (Kemenkes, 2017).

Vegetable Eating Motivation (VEM) merupakan salah satu bentuk terapi bermain yang dirancang oleh peneliti dengan tujuan memberikan motivasi dan edukasi kepada anak prasekolah dengan pendekatan bermain yang dilakukan dalam bentuk rangkaian permainan dan dilakukan selama 6 hari, dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku makan sayuran pada anak prasekolah. Diharapkan dapat memotifasi untuk penerapan *vegetable eating motivation* (VEM) pada anak-anak stunting..

Frekuensi makan sayur anak dapat diukur dengan melihat seberapa sering anak mengonsumsi sayur dalam sehari.

Frekuensi makan sayur yang dianjurkan Menurut Pedoman Gizi Seimbang, anak dianjurkan mengonsumsi 3-4 porsi sayur setiap hari. Setiap kali makan, setengah bagian piring sebaiknya berisi buah dan sayur, dengan lebih banyak sayuran. Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan konsumsi minimal 5 porsi sayur dan buah setiap hari.

Dampak dari kurang makan sayur pada Anak yang jarang makan sayur berisiko mengalami sembelit karena tidak cukup mengonsumsi makanan berserat. Anak yang kurang makan sayur berisiko lebih tinggi mengonsumsi makanan olahan yang tinggi kalori dan rendah serat. Dalam jangka panjang, kekurangan makan sayur dapat menimbulkan masalah lain seperti diabetes dan penyakit jantung.

Agar anak suka makan sayur Libatkan anak dalam memilih serta menyajikan buah dan sayur, Perkenalkan sayur dan buah dengan cara yang menyenangkan, Bentuk kebiasaan makan sayur dan buah, Jadilah contoh, Jangan memaksa atau menghukum anak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebuah penelitian dengan pemilihan judul "Pengaruh penerapan *vegetabel eating motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025". Sehingga dengan adanya penerapan *vegetabel eating motivation* (VEM) terhadap anak stunting pemenuhan gizi seimbang ini anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terhindar dari stunting.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan penelitian ini adalah adakah pengaruh penerapan *vegetable eating motivasion* (VEM) terhadap prilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

1.3. Tujuan penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pengaruh penerapan *vegetable eating motivasion* (VEM) terhadap prilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari peneliti yang penulis lakukan adalah sebagi berikut :

1. Untuk mengetahui frekuensi peningkatan perilaku makan sayur pada anak stuting Usia 3 Tahun di klinik bersalin bidan sumiariani kecamatan medan johor kota medan tahun 2025.

2. Untuk mengindentifikasi pengaruh penerapan *vegetable eating motivasion* (VEM) terhadap prilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Dapat mengetahui stimulasi perkembangan anak, meningkatkan pengetahuan dan motivasi anak dalam konsumsi sayuran sehingga asupan gizi seimbang anak tercukup dan mencegah terjadinya stunting.

b. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Membantu orang tua dan tenaga kesehatan dalam memilih metode yang tepat untuk penerapan *vegetable eating motivation* (VEM) pada anak.

c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa terutama di jurusan kebidanan dan menjadikan bahan ajar kepada mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Stunting

2.1. 1. Pengertian Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kornis yang disebkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Penelitian para ahli sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan gizi pada anak (pendek, kelebihan berat badan, PTM) dimulai dari tumbuh kembang janin dalam kandungan ibu hingga anak berusia 2 tahun (Kuwa, Mane, Ferni, Watu, dan Wega, 2021). Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan, menyebabkan kelainan pada bentuk tubuh, meski pun gen yang ada di dalam sel mampu berkembang secara normal.Pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum lahir tidak dapat disangkal dipengaruhi oleh kesejahteraan fisik dan vitalitas ibu selama masa remajanya. Untuk melindungi dari segala potensi hambatan terhadap pertumbuhan dan kemajuan janin hingga usia dua tahun, upaya kami ditujukan kepada ibu hamil, bayi berusia nol hingga dua puluh tiga bulan, dan remaja pra-nikah Sehingga calon orang tua harus memiliki pengetahuan terkait gizi pada saat kehamilan agar anak dapat terhindar dari stunting (Listyarini & Fatmawati, 2020). Stunting dapat terjadi pada anak secara tidak disadari oleh para calon orang tua, adanya beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya stunting yaitu minimnya pengetahuan calon orang tua

terkait persiapan gizi pada saat kehamilan dan 1000 hari setelah anak lahir, ketidak fahaman orang tua dalam memilih pola asuh, kondisi Berat Badan Lahir Rendah, dan hal yang paling umum yaitu status ekonomi keluarga (Ariati, 2019). Persoalan stunting memerlukan perhatian yang lebih besar, dikarenakan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak bisa sangat luas dan bertahan lama, berpotensi menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif mereka jika tidak ditangani dengan hati-hati (Nirmalasari, 2020). Stunting dapat berdampak buruk pada kapasitas belajar karena perkembangan kognitif yang memiliki gangguan. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat sangat memengaruhi kehidupan seseorang di masa dewasa seperti, membatasi prospek pendidikan, pilihan pekerjaan, dan potensi pendapatannya (Kemenkes, 2018). Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya obesitas pada stadium lanjut yang mengkhawatirkan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit tidak menular, termasuk diabetes, hipertensi, dan kanker.

Kondisi tubuh anak yang pendek seiringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tua, sehingga banyak masyarakat yang hanya menerima tanpa berbuat apa apa untuk mencegahnya. Padahal seperti yang kita ketahui, genetika merupakanfaktor determinan kesehatan yang paking kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan politik serta pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya dapat dicegah. Stunting bisa dicegah dengan menerapkan makan buah dan sayur kepada anak.

Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahkanya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali kali tidak beragam. Istlah “Isi

Piringku" dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu porsi makanan, setengahnya piring diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi lebih banyak dari pada karbohidrat.

Perilaku makan sayur pada anak sayur dan buah meroakan sumber zat besi mikro yang sangat bermanfaat bagi tubuh, karena kedua komponen gizi tersebut sangat penting dalam proses metabolisme tubuh sebagai zat pengatur dan antibodi juga bermanfaat menurunkan insiden terkena penyakit kronis. Sayur dan buah merupkan makanan yang penting yang harus selalu dikonsumsi setiap kali makan, tidak hanya bagi orang dewasa mengkonsumsi sejka usia anak anak terutama pada anak usia prasekolah yakni 3-6 tahun karena pada usia tersebut merupakan mas emas untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi anak tersebut merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi anak – anak.

Faktor risiko stunting cenderung lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, kebiasaan hidup sehat dan bersih yang dapat berpengaruh pada kejadian diare juga (Modern, Sauli, and Mpolya 2020), Faktor risiko stunting cenderung lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, kebiasaan hidup sehat dan bersih yang dapat berpengaruh pada kejadian diare juga (Modern, Sauli, and Mpolya 2020),

Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (BKKBN, 2022) tahun 2022 mengungkapkan bahwa Sumatera Utara merupakan lokasi yang cukup memprihatinkan akibat dari adanya stunting ini. Konsumsi sayur pada anak masih sangat minim dan masih banyak yang belum sesuai dengan rekomendasi. Rekomendasi kecukupan konsumsi sayur

Konsumsi sayur pada anak masih sangat minim dan masih banyak yang belum sesuai dengan rekomendasi.

Rekomendasi kecukupan konsumsi sayur untuk anak prasekolahadalah 100 gram (setara dengan 1 porsi atau 1 gelas sayur). Di Indonesia juga diperoleh data bahwa konsumsi sayur masyarakat masih relatif rendah, padahal di Indonesia merupakan negara agraris dengan komoditi sayur lokal yang melimpah. Intervensi remaja dapat diterapkan kapan saja dalam siklus hidup untuk mencegah meningkatnya prevalensi stunting. Dengan mengedukasi calon ibu tentang stunting sejak dini, kita dapat memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak pada 1000 hari pertama.

Tanaman sawi merupakan tanaman sayuran yang memiliki nilai gizi tinggi yang mampu dijadikan sebagai salah satu upaya pencegah stunting. Kandungan yang ada di tanaman sawi kaya akan vitamin A, B, C, E dan K. dimana sawi juga mengandung karbohidrat, protein, dan lemak baik yang berguna untuk kesehatan tubuh.

2.2. Penyebab Stunting

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa stunting merupakan permasalahan yang sekarang menjadi prioritas pemerintah dan juga masyarakat dalam membantu turunnya angka stunting di Indonesia (Rokom, 2023). Stunting, sebuah konsekuensi yang mengkhawatirkan dari kekurangan gizi kronis pada anak-anak, menimbulkan gangguan pertumbuhan linier yang menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan.(Kemenkes, 2018). Stunting dapat diketahui melalui evaluasi

komprehensif terhadap tinggi badan anak, dimana pengukurannya diperiksa secara cermat berdasarkan serangkaian tolok ukur yang diakui secara universal dan telah ditentukan sebelumnya. Diakui secara luas dalam skala global bahwa anak-anak dianggap stunting jika panjang atau tinggi badan merekaberada di bawah -2 standar deviasi dari nilai median yang ditetapkan oleh Standar Pertumbuhan Anak WHO untuk usia dan jenis kelamin mereka (WHO 2008; de Onis et al.2013). Demikian pula, anak-anak diklasifikasikan sebagai stunting berat jika panjang atau tinggi badan mereka berada di bawah -3 standar deviasi dari median Standar Pertumbuhan Anak WHO untuk usia dan jenis kelamin mereka.

Stunting memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan anak dan masa depan anak, dimana stunting dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan fisik anak (Pradana Putri & Rong, 2021), menghambat pertumbuhan kognitif anak sehingga berpengaruh pada kualitas belajar anak di sekolah serta dapat menyebabkan adanya penurunan produktivitas di usia dewasa yang akan datang dan dapat menyebabkan adanya penyakit tidak menular (Dinkes, 2019). Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi yang didapatkan anak dari makanan yang dikonsumsi anak dimana kekurangan protein dan asupan energi anak sangat berpengaruh dalam faktor penyebab terjadinya stunting pada anak (Sinaga et al. 2019).

Fitri (2012) menemukan korelasi yang menarik antara konsumsi energi dan prevalensi stunting pada anak kecil di Sumatera. Kurangnya nutrisi penting, khususnya energi, secara langsung menghambat perkembangan fisik makhluk tak berdosa ini. Lebih lanjut, Sihadi & Djaiman (2011) menjelaskan rendahnya

konsumsi energi menjadi pemicu utama terjadinya stunting pada balita di Indonesia. Fenomena yang menyedihkan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya pendidikan ibu mengenai stunting dan kegagalan ibu dalam memberikan pola makan yang seimbang, serta berkurangnya nafsu makan pada anak akibat sakit.

Tingkat pendidikan seorang ibu mempunyai peranan yang besar terhadap kemungkinan terjadinya stunting pada anak. Pendidikan ibu sangat penting dalam menyediakan makanan, mengasuh, dan merawat anak (Margawati & Astuti, 2018). Ketika seorang ibu memiliki pemahaman yang mendalam, formulasi strategi pengasuhan anak menjadi lebih baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan luas tentang gizi akan mahir menangani pengolahan makanan, menyusun menu yang seimbang, dan menjamin kualitas dan kebersihan makanan yang terbaik. Dengan demikian, angka kejadian stunting pada anak diperkirakan akan berkurang.

Selain ibu, peran ayah juga dapat menjadi faktor terjadinya stunting pada anak dikarenakan pekerjaan ayah akan berpengaruh pada jumlah penghasilan yang didapatkan (Noviastuti, 2018). Permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan sosial ekonomi dimana besarnya pendapatan suatu keluarga berdampak langsung pada kemampuan menyediakan energi dan protein yang cukup bagi anak (UNICEF, 2012). Hal ini terkait dengan kemampuan beli keluarga. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan stunting adalah imunisasi, imunisasi berperan dalam terjadinya stunting, karena anak yang tidak mendapat imunisasi lebih rentan terkena penyakit yang erat kaitannya dengan stunting (Noviastuti, 2018).

2.3. Faktor – faktor penyebab stunting

Adapun beberapa faktor penyebab stunting :

- Asupan gizi : kurang akses terhadap makanan bergizi, rendahknay asupan vitamin dan mineral dan buruknya keragaman pangan.
- Pola asuh : pola asuh keluarga yang kurang tepat.
- Pengetahuan keluarga : minimnya pengetahuan keluarga khususnya orang tua.
- Situasi keluarga : ekonomi yang rendah hidup terpisah dari orang tua baik perceraian maupun kematian.
- Budaya : adanya peraturan atau kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan anak.
- Asupan nutrisi : selama kehamilan nutrisi yang kurang menyebabkan anak yang dikandung ibu mengalami kekurangan asupan, diet agar kurus
- kurang mengkonsumsi sayur dan buah : jika tubuh kurang mengkonsumsi sayur dan buah akan menyebabkan stunting.

2.4. Gejala Stunting

Stunting memberikan gejala yang bervariasi, tak hanya melibatkan terhambatnya pertumbuhan fisik, namun stunting juga mampu menghambat perkembangan kognitif, dan masalah kesehatan lainnya. Indikasi awal stunting seringkali luput dari deteksi dan pengenalan, bahkan luput dari perhatian kita hingga terlambat. Namun demikian, di antara tanda-tanda yang mungkin terlihat pada anak-anak yang mengalami pertumbuhan terhambat, kami menemukan berkurangnya perkembangan fisik, ukuran fisik yang lebih kecil dibandingkan teman sebayanya, gangguan perkembangan gigi, serta

penurunan perhatian kognitif dan retensi memori.Anak-anak yang menderita stunting menunjukkan berbagai gejala, terutama pertumbuhan tubuh yang lebih lambat dibandingkan teman sebayanya.

Anak-anak ini seringkali menunjukkan tinggi badan yang lebih kecil dibandingkan dengan usia mereka, kibat dari kekurangan gizi kronis. Selain perawakan mereka yang lebih kecil, anak-anak yang mengalami stunting sering kali memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lainnya, sehingga hal ini menjadi indikator jelas adanya kekurangan gizi. Jelaslah bahwa anak-anak ini gagal mengalami peningkatan berat badan yang diharapkan seiring kemajuan mereka melalui tahap perkembangan.

Stunting juga dapat berdampak pada perkembangan pubertas anak. Anak yang mengalami stunting mungkin mengalami pubertas lebih lambat dibandingkan dengan teman sebaya mereka. Karena stunting menghambat pertumbuhan fisik, anak yang mengalaminya mungkin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

Gangguan kognitif adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam berpikir, mengingat, belajar, berbahasa, dan berkomunikasi. Anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan menghadapi kerentanan yang lebih besar dibandingkan anak-anak sebayanya. Selain itu, anak-anak ini sering mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi pada pelajaran, menunjukkan ketidakstabilan emosi, dan menunjukkan berkurangnya tingkat keterlibatan dalam lingkungan sekolah (Supradewi, 2023).

Sebagaimana dikutip Pratiwi dalam Sari (2021), dampak stunting pada anak diwujudkan dalam bentuk tantangan dalam perjalanan pendidikannya dan terhambatnya prestasi akademik. Masalah ini mempunyai dampak yang sangat besar, karena tidak hanya menghambat kemampuan kognitif anak tetapi juga menghambat kemajuan dan kesuksesan akademis mereka secara keseluruhan.Selain itu, dampak besar dari stunting terhadap anak-anak juga tidak boleh diabaikan. Dampak buruk dari stunting meliputi berkurangnya vitalitas dan terbatasnya mobilitas fisik, sehingga menghambat potensi pencapaian masa depan dan kesejahteraan secara keseluruhan

2.5. Cara meningkatkan konsumsi makan sayur pada anak

Menurut anjuran WHO, konsumsi sayur dan buah adalah 400 gram per orang per hari, ya3g terdiri dari 250 gram sayur (setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan) dan 150 gram buah. WHO dan Food and Agriculture Organisation (FAO) menyebutkan, kekurangan asupan buah dan sayur dapat menyebabkan risiko kematian akibat kanker saluran cerna sebesar 14%, risiko kematian akibat penyakit jantung koroner sebesar 11%, dan kematian akibat stroke sebanyak 9%. Edukasi gizi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan gizi anak sekolah, membentuk sikap positif terhadap makanan dalam rangka membentuk kebiasaan makan yang baik (Azhari and Fayasari, 2020).

Pemberian edukasi yang tepat bagi masyarakat terutama anak sekolah diharapkan nantinya akan dapat membantu meningkatkan prevalensi konsumsi sayur dan buah di Indonesia. Menurut Riskesdas tahun 2018, diketahui anak usia >5 tahun di Indonesia angka konsumsi sayur dan buah paling dominan pada

kelompok 1-2 porsi per hari dalam seminggu sebesar 71,73%. Sedangkan >5 porsi konsumsi sayur dan buah hanya sebesar 2.28% (Balitbangkes, 2018).

Berikut adalah beberapa cara meningkatkan konsumsi makan sayur pada anak :

a). Penerana *vegetabel eating motivation* (vem)

Vegetabel eating motivation (VEM) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perilaku anak makan sayur dengan kegiatan makan sayur yang memungkinkan anak –anak untuk makan sayuran secara tratur atau membuat sayuran favorit yang memungkan anak – anak untuk memilih sayuran yang mereka sukai.

b). Perlaku makan sayur pada orang tua

Anak – anak sering meniru orang tua mereka dalam mengkonsumsi sayuran jadi peran orang tua sangat penting dalam m eningkatkan perilaku anak dalam makan sayur dan mencegah terjadinya stuting.

c). Buat sayuran menjadi menarik

- Potong sayuran menjadi bentuk yang menarik, seperti bunga atau hewan.
- Tambahkan sayuran ke dalam makanan yang disukai anak, seperti pasta atau pizza.
- Buat salad sayuran dengan saus yang lezat.

d). Libatkan anak dalam proses memasak

- Ajak anak untuk membantu memilih sayuran di pasar atau toko.
- Libatkan anak dalam proses memasak, seperti mencuci sayuran atau mengaduk sayuran.

e). Buatkan sayuran menjadi mudah diakses atau dijangkau

- Simpan sayuran di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dalam kulkas atau di atas meja.

- Siapkan sayuran yang sudah dicuci dan dipotong, sehingga anak dapat langsung memakannya.

f). Berikan pujian dan penghargaan

- Berikan pujian kepada anak ketika mereka memakan sayuran.

- Berikan penghargaan, seperti stiker atau hadiah kecil, ketika anak mencapai target konsumsi sayuran.

g). Edukasi anak tentang manfaat sayuran

- Berikan penjelasan tentang manfaat sayuran bagi kesehatan.

- Tunjukkan contoh-contoh sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral.

h). Buat sayuran menjadi menyenangkan

- Buat permainan yang melibatkan sayuran, seperti "mencari sayuran" atau "sayuran yang tersembunyi".

- Buat cerita atau lagu yang melibatkan sayuran.

2.6. Menu makanan yang bergizi untuk mencegah stunting pada anak

Dalam mencegah stunting, penting untuk memilih makanan yang mengandung nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai nutrisi yang terkandung dalam beberapa jenis makanan untuk stunting yang direkomendasikan:

A. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang merah mengandung protein nabati yang penting untuk pembentukan jaringan tubuh. Selain itu,

kacang-kacangan juga mengandung zat besi dan serat yang dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dan memperbaiki pencernaan anak.



Gambar 2. 1. Kacang-Kacangan

B. Daging Ayam

Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang mudah dicerna oleh tubuh anak-anak. Protein diperlukan untuk pertumbuhan otot, kulit, rambut, dan jaringan tubuh lainnya. Selain itu, daging ayam juga mengandung zat besi dan vitamin B kompleks yang penting untuk kesehatan darah dan sistem saraf.



Gambar 2. 2. Daging Ayam

C. Telur

Telur mengandung protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh manusia. Selain itu, telur juga mengandung kolin,

vitamin B12, zat besi, dan seng yang penting untuk perkembangan otak dan fungsi kognitif anak.



Gambar 2. 3. Telur

D. Ikan

Ikan menjadi makanan untuk stunting karena merupakan sumber asam lemak omega-3 yang esensial untuk perkembangan otak dan sistem saraf. Asam lemak omega-3 juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi risiko peradangan dan penyakit kronis pada anak.



Gambar 2. 4. Ikan

E. Tempe dan Tahu

Tempe dan tahu adalah sumber protein nabati yang rendah lemak dan kaya akan serat. Keduanya mengandung zat besi, kalsium, dan magnesium yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang anak.



Gambar 2. 5. Tempe Dan Tahu

F. Hati Ayam

Hati ayam adalah salah satu sumber zat besi heme terbaik yang dapat membantu mencegah anemia pada anak-anak. Zat besi heme lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi non-heme yang terdapat dalam makanan nabati.



Gambar 2. 6. Hati Ayam

G. Buah Beri

Buah beri seperti blueberry, raspberry, dan strawberry mengandung antioksidan tinggi yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Selain itu, buah beri juga mengandung vitamin C dan serat yang baik untuk sistem kekebalan tubuh dan pencernaan anak.



Gambar 2. 7. Buah Beri

H. Sayuran

Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung mengandung banyak zat besi, kalsium, dan magnesium yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang anak. Selain itu, sayuran juga mengandung vitamin A, C, dan K yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh.



Gambar 2. 8. Sayuran

2.7. Vegetable Eating Motivation (VEM)

2.7.1. Pengertian Vegetabel Eating Motivation (VEM)

Vegetable eating motivation (VEM) adalah suatu konsep yang mengacu pada motivasi atau dorongan seseorang untuk mengkonsumsi sayuran. VEM meliputi berbagai faktor yang mempengaruhi keinginan dan kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi sayuran seperti pengetahuan tentang manfaat

sayuran dikarenakan semakin banyak pengetahuan tentang manfaat sayuran semakin tinggi motivasi untuk mengkonsumsinya, pengalaman mengkonsumsi sayuran yang posistif dapat meningkatkan motivasi untuk mengkonsumsi sayuran, ketersedian dan akseblilitas sayuran yang baik dapat meningkatkan motivasi untk mengkonsumsinya, pengaruh sosial dari keluarg, teman dan masyarakat juga dapat mempengaruhi motivasi dalam mengkonsumsi sayuran, keperibadian dan sikap seseorang terhadap sayuran juga dapat memepengaruhi motivasi untuk mengkonsumsinya.

Pemberian makanan yang seimbang diperlukan karena tubuh membutuhkan makanan yang mengandung semua nutrien (protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air). Tujuan pemberian makanan pada anak bukan sekadar membuat kenyang, tetapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untukkeperluan hidup serta mendidik anak untuk membina selera dan kebiasaan makan yang sehat. Anak-anak yang tidak memperoleh asupan gizi yang seimbang karena pola makan yang buruk akan terjadi malnutrisi yang menyebabkan sistem imunitas anak berkurang, pertumbuhan dan perkembangan terhambat, sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap usianya.

Kegagalan pencapaian tumbuh kembang dan kecerdasan pada usia 0-2 tahun akan bersifat permanen. Dampak jangka pendek adalah terjadinya gangguan pertumbuhan, perkembangan otak dan metabolism, akibat jangka panjangnya adalah stunting (pendek). (Munawaroh et al., 2022).

Kebutuhan nutrisimerupakan kebutuhan yang sangat penting dalam membantu proses pertumbuhan danperkembangan anak serta dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat kurang nutrisidalam tubuh. Oleh sebab itu, makanan yang dikonsumsi anak sebaiknya beraneka ragam danmengandung berbagai vitamin. Dalam pertumbuhan anak diperlukan gizi yang seimbang, supaya seluruh anggotabadan dapat tumbuh secara wajar, pertumbuhan otot dan tulang dapat kuat, dan sehat. Beberapa sumber gizi yang sangat berguna tersebut terkandung di dalam sayuran (Sukamti,1994) (Hermina & S, 2016). Sayuran merupakan sumber vitamin, mineral, dan kaya akan seratyang sangat mudah ditemukan di dalam bahan makanan. Mengkonsumsi makanan berseratsangat baik karena dapat membantu memperlancar proses pencernaan didalam tubuh,mempengaruhi peningkatan ukuran, berat, dan melunakkan feses (Kusharto, 2007).

Karena pentingnya konsumsi buah dan sayur, organisasi pangan dan pertanian duniaFood and Agriculture Organization (FAO), merekomendasikan warga dunia untuk makansayur dan buah secara teratur sebanyak 75 kg/kapita/tahun begitupun dengan World HealthOrganization (WHO) merekomendasikan agar konsumsi sayur dan buah sebanyak 400 gramsetiap hari (Indira, 2015).

Menurut Soetjiningsih kebutuhan gizi, memberikan makanan yang benar pada anakharus dilihat dari banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, disamping aspekmedik dari anak itu sendiri. Makanan pada anak usia dini harus serasi, selaras dan seimbang.Serasi artinya sesuai dengan tingkat tumbuh kembang anak. Selaras adalah sesuai dengankondisi ekonomi, sosial budaya serta agama

dari keluarga. Sedangkan seimbang artinya nilaigizinya harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usia dan jenis bahan makanan sepertikarbohidrat, protein dan lemak (Laode Anhusadar, 2020).S

Selain itu, anak Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh bermain untuk meningkatkan minat makan sayuran bagi anak usia prasekolah, salah satunya dengan bermain storytelling efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam mengkonsumsi sayur pada anak usia prasekolah (Ilya Krisnana, Yuni Sufyanti Arief, 2015).

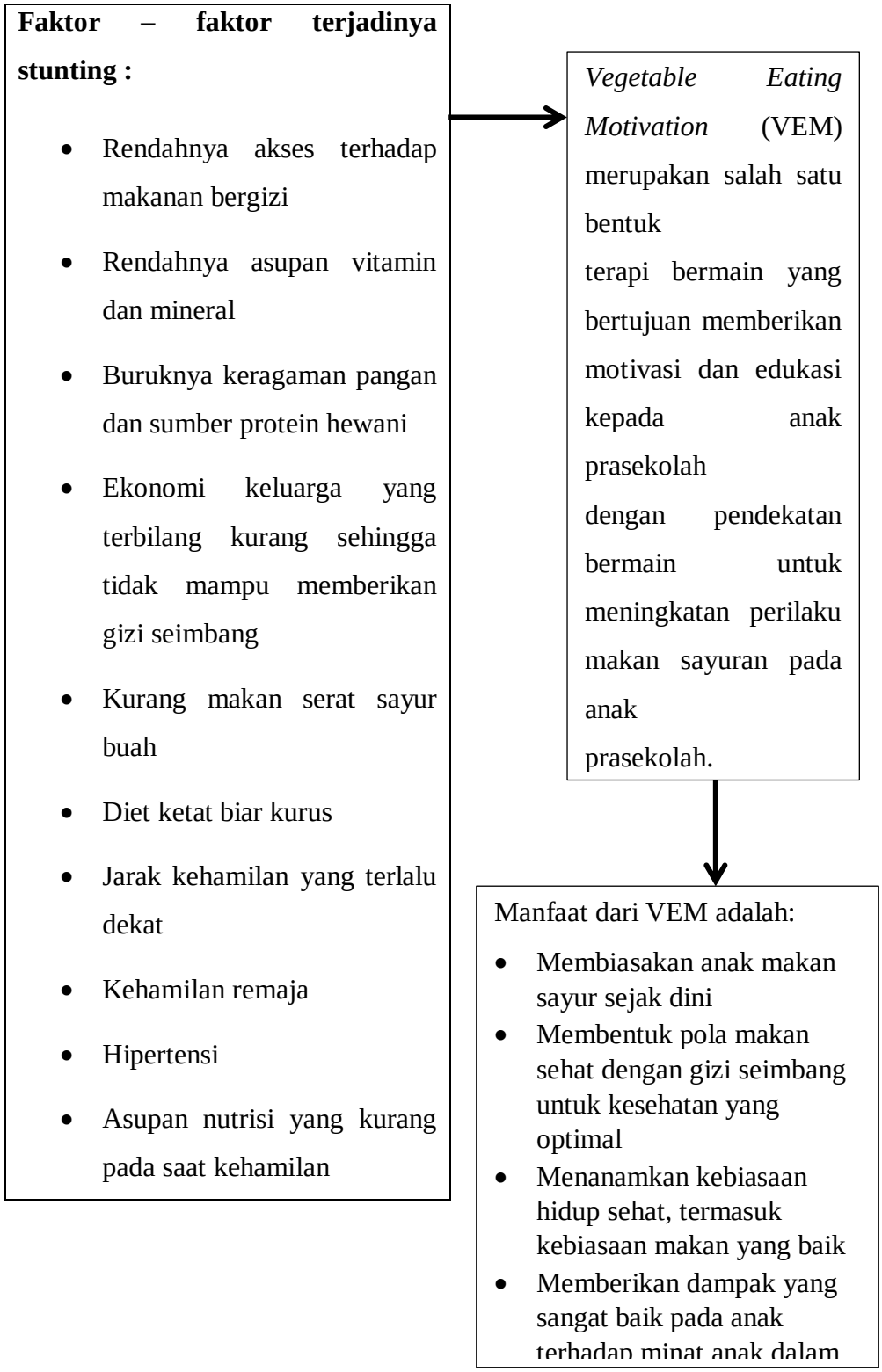
Penelitian lain menyimpulkan bahwa Kedua bermain peran mikro tersebut sama-sama memiliki pengaruh dalam kecerdasan interpersonal anak, namun bermain peran mikro bebas memberikan hasil lebih baik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dibandingkan bermain peran mikro tepimpin. Dengan demikian, hal ini merupakan bukti empiris bahwa kecerdasan interpersonal anak yang diberikan bermain peran mikro bebas lebih tinggi dibandingkan anak yang diberikan bermain peran mikro terpimpin. Maka dapat direkomendasikan bahwa bermain peran mikro bebas lebih cocok diterapkan dalam Kecerdasan interpersonal (Damayanti, Ch, & Hapidin, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, Syukri, & Halida, 2017) yang berjudul “Peningkatan motivasi anak makan sayuran melalui metode bermain permainan cooking class pada anak usia 4-6 tahun” menemukan bahwa, melalui metode bermain permainan cooking class dapat meningkatkan motivasi anak makan sayuran pada anak usia 4-6 tahun di RA AL- Muhajirin Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Vegetable Eating Motivation (VEM) merupakan salah satu bentuk permainan yang dirancang

oleh peneliti dengan tujuan memberikan motivasi dan edukasi kepada anak prasekolah dengan pendekatan bermain yang dilakukan dalam bentuk rangkaian permainan dan dilakukan selama 6 hari, dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku makan sayuran pada anak prasekolah.

Berdasarkan hasil observasi awal kepada 16 orang anak prasekolah di TK Asma Jaya Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, 100 % Ibu selalu menghidangkan menu sayur setiap hari. Akan tetapi, 11 Anak diantaranya menolak untuk memakan sayur, Anak lebih memilih nasi dan lauk saja seperti telur, ikan dan ayam. Anak yang menolak makan sayuran mengatakan tidak menyukai sayuran karena rasanya yang pahit, hambar, teksturnya lama dikunyah, Peneliti juga melakukan wawancara kepada 10 orang ibu dari anak prasekolah di TK Asma Jaya 8 orang ibu mengatakan anaknya sulit jika disuruh makan sayur, 2 orang ibu mengatakan anaknya mau makan sayuran. Melihat perilaku anak prasekolah yang jarang sekali suka dengan sayuran dan hari-hari mereka dipenuhi dengan bermain, maka dibutuhkanlah sebuah terapi dengan pendekatan bermain yang dapat memotivasi dan meningkatkan konsumsi sayuran pada anak prasekolah.dapat mengalami *stunting* atau menjadibalita pendek (KemenkesRI, 2016).

2.8. Kerangka teori



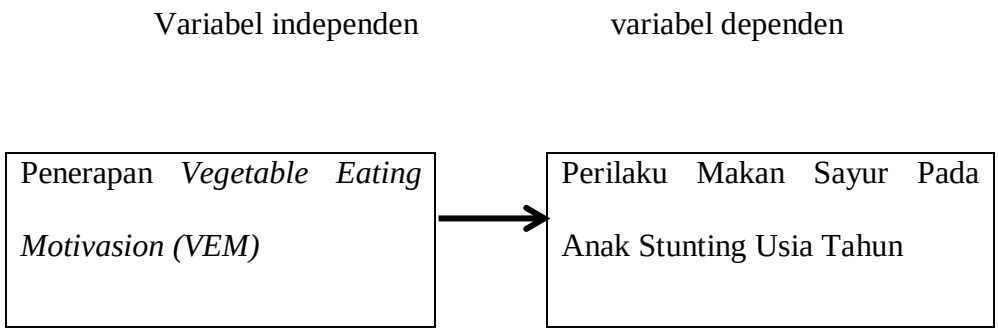
2.9. Kerangka konsep

Kerangka konsep dalam penelitian dapat menggambarkan hubungan antara konsepkonsep yang akan diukur dan yang akan diamati di dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Diagramd kerangka konsep menunjukkan bagaimana variabel-variabel yang akan diteliti saling terkait satu sama lain (Adiputra et al, 2021).

Kerangka konsep ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025, dilandasan berpikir dalam melakukan penelitian di jelaskan dalam kerangka kosep sebagai berikut :

Variabel independen variabel dependen penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* perilaku makan sayur pada anak stunting.

Tabel 2. 1. Kerangka kosep



Gambar diatas menggambarkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

2.9.1. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris (Setyawan 2021).

Ha : Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) Terhadap Perilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental, yaitu suatu prosedur penelitian yang dilakukan dengan memberikan perlakuan/intervensi pada subyek penelitian, dengan tujuan menilai pengaruh suatu perlakuan pada variabel independen terhadap variabel dependen. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan *quasy exsperimental* (eksperimental semu). Disebut demikian karena eksperimen jenis ini belum memenuhi persyaratan seperti cara dapat dikatakan ilmiah mengikuti peraturan-peraturan tertentu (Arikunto, 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain *One Group Pre Test and Post Test Design*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menilai satu kelompok, dengan uji wilcoxon. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) Terhadap Perilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

3.2. Waktu dan lokasi penelitian

3.2.1. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini adalah dimana waktu penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret – April 2025.

3.2.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan dilokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Klinik bersalin bidan sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

3.3. Populasi dan sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generelalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi didalam penelitia ini anak stunting Usia 3 Tahun berjumlah 30 orang di Klinik bersalin bidan sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau bagian yang diambil dari keseluruhan objek atau sasaran yang diteliti yang dianggap telah mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah "*total sampilng"* Menurut Sugiono (2010), sampling jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel penelitian sebanyak 30 orang anak stunting usia 3 Tahun.

3.4. Variabel dan definis operasional

3.4.1. Variabel

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai terhadap sesuatu (benda, manusia dan lain-lain). Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel dalam peneltian ini terdiri atas 2 variabel yaitu:.

1. Variabel independen

Variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. Dalam penelitian ini variabel independen adalah Penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM).

2. Varibel dependen

Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Dalam peneltian ini variabel dependen adalah Perilaku Makan Sayur Pada Anak Usia 3 Tahun .

3.4.2. Defenisi operasional

Defenisi operasioanal merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasioanal sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam pengertian makna dalam penelitian (Notoatmodjo, 2019).

Tabel 3. 1. Variabel dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi perasional	Alat ukur	Hasil ukur	Skala
1	**Variabel independen** (Penerapan Vegetable Eating (VEM)	Vegetable eating motivation (VEM) adalah suatu konsep yang mengacu pada motivasi atau dorongan	Kuesioner	1. Sebelum Dilakukan 2. Sesudah dilakukan	Nominal

		seseorang untuk mengkonsumsi sayuran.			
2	**Variabel dependen:** penerapan Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun	Perilaku sayur pada anak adalah suatu pola perilaku yang berkaitan dengan konsumsi sayuran pada anak-anak.	Lembar observasi	1. Frekuensi Normal >1x/hari 2. Frekuensi Kurang < 1x/hari 3. Sangat Kurang	Nominal

3.5. Etika penelitian

Menurut Notoatmodjo (2019), dalam melaksanakan peneltitian khususnya jika yang menjadi subjek penelitian adalah manusia, maka peneliti harus memahami kebebasan dalam menentukan dirinya, sehingga peneliti yang akan dilaksanakan benar-benar menjunjung tinggi kebebasan manusia. Masalah etika penelitian kebidanan merrupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian,

mengingat penelitian kebidanan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan terutama yaitu:

3.5.1. Lembar persetjuan (informen concent)

Informed Concent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan *Informed Concent* tersebut diberikan sebelum penelitian di lakukan dengan lembar persetujuan menjadi responden. Tujuan *Informed Concent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia maka peneliti harus menjaga hak responden.

3.5.2. Tanpa nama (anominity)

Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang memebrika jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan atau hasil penelitian yang akan di sajikan.

3.5.3. Kerahasian (confidenciality)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang di kumpulkan di jamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan di laporkan pada hasil riset.

3.6. Prosedur penelitian

3.6.1. Persiapan

1. Peneliti mengkaji Pengaruh penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun.
2. Peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat prosedur penelitian kepada calon responden menandatangani surat persetujuan menjadi calon responden (*Informed Concent)* setelah mengerti dan setuju terlibat dalam penelitian.

3.6.2. Pengumpulan data

Peneliti akan melakukan pemeriksaan pada Perilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting dengan Penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM). Setelah dilakukan tindakan maka peneliti akan mengumpulkan hasilnya kemudian akan memperoleh data tersebut. Dikarenakan keterlambatan waktu yang menyebabkan peneliti tidak dapat mengumpulkan responden sebanyak mungkin menyebabkan peneliti hanya dapat mengumpulkan sebanyak 30 responden saja.

3.7. Analisis data

2.7.1. Analisis univariat

Analisis Univariat pada penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran setiap variabel yang diteliti. Bentuk pengkajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi dan selanjutnya dilakukan analisa terhadap tampilan data tersebut untuk mengetahui sebaran dari masing-masing variabel.

3.7.2. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua kelompok data yaitu Variabel Independent (*Vegetable Eating Motivation* (VEM)) dan Variabel Dependent (Perilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting). Analisis Deskriftif yang digunakan adalah uji statistik parametrik dependen wilxocon signet req untuk memperoleh rata-rata nilai pretest dan rata-rata nilai posttest sehingga dapat dibandingkan intensitas sesudah dilakukan terapi pijat bayi untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan d Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang berada Gg. Kasih Dalam Gg. Kasih X No.69 J, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219. penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang menggunakan data berupa kuesioner yang di berikan kepada orang tua anak untuk mencatat seberapa sering anak mengkonsumsi sayuran, adapun gambaran dari Klinik Bersalin Bidan Sumiariani, klinik sumiariani adalah klinik yang memliki pelayanan yang baik, ramah, dan nyaman ”

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan umur bayi, jenis kelamin,berat badan, frekuensi makan sayur. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

Tabel 4. 1. Distribusi Karakteristik Responden Pengaruh penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun

No.	Variable	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Umur 3 Tahun	30	100,0
2.	Jenis kelamin Laki-laki Perempuan	 16 14	 53,3 46,7

3.	Berat badan 8 kg 9 kg	12 18	40,0 60,0
4.	Frekuensi makan sayur Frekuensi Normal >1x/hari Frekuensi Kurang <1x/hari Sangat kurang	11 11 8	36,7 36,7 26,7
	Total	**30**	**100,0**

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukan 30 responden, sebagian besar karakteristik responden pada umur 3 Tahun 30 orang (100,0%), jenis kelamin Laki-laki 16 orang (53,3%), berjenis kelamin perempuan 14 orang (46,7%), berat badan 8 kg sebanyak 12 orang (40,0%), 9 kg sebanyak 18orang (60,0%).

4.3. Analisis Data

4.3.1. Hasil Analisis Univariat

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentase dari variabel-variabel penelitian. Sebelum dan sesudah di lakukan Pengaruh penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun. Data disajikan dalam bentuk tabel dan teks dibawah ini:

Tabel 4. 2. Distribusi Responden *pre-test* dan *post test* frekuensi makan sayur pada anak stunting usia 3 tahun dengan terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun

No	Frekuensi Makan Sayur	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Frekuensi Normal >1x/hari	4	
	Frekuensi Kurang <1x/hari	16	76,0
	Sangat kurang	10	24,0
2	Frekuensi Kurang <1x/hari	17	56,7

Frekuensi Kurang <1x/hari	11	36,7
Sangat kurang	2	6,7
Total	30	100,0

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 10 responden, sebagian besar responden berdasarkan *pre test* pemberian therapy pijat bayi dengan pengurangan kholik pada bayi usia 3-6 bulan yaitu dalam kategori Sangat Tidak Normal sebanyak (76,0%) untuk ketegori tidak normal sebanyak (24,0%) Sedangkan *post test* setalah pemberian therapy pijat bayi dengan pengurangan kholik pada bayi usia 3-6 bulan yaitu Tidak normal (20,0%) dan Normal sebanyak (80,0%) dengan total (100.0%).

4.3.2. Hasil Analisis Bivariat

Pengujian selanjutnya adalah analisis bivariat, analisis bivariat dilakukan untuk mengindetifikasi hubungan antara dua variabel. Untuk melihat pengaruh pemberian therapy pijat bayi dengan pengurangan kholik pada bayi usia 3-6 bulan sebelum dan dan sesudah dilakukan pemberian therapy pijat bayi pada kelompok responden (*pre* dan *post*) menggunakan Uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Adapun hasil analisis bivariat dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3. Uji wilcoxon Pengaruh penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) terhadap perilaku makan sayur pada anak stunting Usia 3 Tahun tahun 2025

Perlakuan	N	Mean	*Std. Deviation*	*Pvalue*
Pre	30	13,00	0,422	0,001
Post	30	10,00	0,422	

Berdasarkan tabel 4.3 di peroleh hasil nilai rata- rata frekuensi makan sayur oada anak stunting usai 3 tahun sebelum dan sesudah di lakukan penerapan penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM)**,** nilai sebelum dilakukan penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) adalah 13,00 dan nilai sesudah dilakukan penerapan *Vegetable Eating Motivation* (VEM) pada anak stunting usia 3 tahun 10,00 dengan menggunakan uji *statistic* Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh p=0,001 (p<0,05) maka terbukti bahwasannya ada mengetahui Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Analisis Univariat

5.1.1 Responden Responden *pre-test* dan *post test* Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 30 responden, sebagian besar responden berdasarkan *pre test* Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun yaitu dalam kategori frekuensi Normal >1x/hari (13,3%) untuk ketegori frekuensi Kurang<1x/hari (53,3%), sangat kurang (33,3%) dan *post test* Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun yaitu frekuensi Normal >1x/hari (56,7%) dan frekuensi Kurang<1x/hari (36,7%) sangat kurang (6,7%) dengan total (100.0%).

Vegetable Eating Motivation (VEM) merupakan salah satu bentuk terapi bermain yang dirancang oleh peneliti dengan tujuan memberikan motivasi dan edukasi kepada anak prasekolah dengan pendekatan bermain yang dilakukan dalam bentuk rangkaian permainan dan dilakukan selama 6 hari, dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku makan sayuran pada anak prasekolah. Diharapkan dapat memotifasi untuk penerapan *vegetable eating motivation* (VEM) pada anak-anak stunting..

Frekuensi makan sayur anak dapat diukur dengan melihat seberapa sering anak mengonsumsi sayur dalam sehari.

Frekuensi makan sayur yang dianjurkan Menurut Pedoman Gizi Seimbang, anak dianjurkan mengonsumsi 3-4 porsi sayur setiap hari. Setiap kali makan, setengah bagian piring sebaiknya berisi buah dan sayur, dengan lebih banyak sayuran. Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan konsumsi minimal 5 porsi sayur dan buah setiap hari.

Dampak dari kurang makan sayur pada Anak yang jarang makan sayur berisiko mengalami sembelit karena tidak cukup mengonsumsi makanan berserat. Anak yang kurang makan sayur berisiko lebih tinggi mengonsumsi makanan olahan yang tinggi kalori dan rendah serat. Dalam jangka panjang, kekurangan makan sayur dapat menimbulkan masalah lain seperti diabetes dan penyakit jantung.

Agar anak suka makan sayur Libatkan anak dalam memilih serta menyajikan buah dan sayur, Perkenalkan sayur dan buah dengan cara yang menyenangkan, Bentuk kebiasaan makan sayur dan buah, Jadilah contoh, Jangan memaksa atau menghukum anak.

5.2. Analisis Bivariat

5.2.1 Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun

Berdasarkan tabel 4.3 di peroleh hasil nilai rata- rata Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun sebelum dan sesudah dilakukan Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM*i, nilai sebelum dilakukan Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* adalah 13,3 dan nilai sesudah dilakukan Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* 56,7 dengan menggunakan uji *statistic* yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh p=0,000 (p<0,05) maka terbukti bahwasannya ada

Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun.

Vegetable Eating Motivation (VEM) merupakan salah satu bentuk terapi bermain yang dirancang oleh peneliti dengan tujuan memberikan motivasi dan edukasi kepada anak prasekolah dengan pendekatan bermain yang dilakukan dalam bentuk rangkaian permainan dan dilakukan selama 6 hari, dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku makan sayuran pada anak prasekolah. Diharapkan dapat memotifasi untuk penerapan *vegetable eating motivation* (VEM) pada anak-anak stunting..

Penelitian lain menyimpulkan bahwa Kedua bermain peran mikro tersebut sama-sama memiliki pengaruh dalam kecerdasan interpersonal anak, namun bermain peran mikro bebas memberikan hasil lebih baik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dibandingkan bermain peran mikro tepimpin. Dengan demikian, hal ini merupakan bukti empiris bahwa kecerdasan interpersonal anak yang diberikan bermain peran mikro bebas lebih tinggi dibandingkan anak yang diberikan bermain peran mikro terpimpin. Maka dapat direkomendasikan bahwa bermain peran mikro bebas lebih cocok diterapkan dalam Kecerdasan interpersonal (Damayanti, Ch, & Hapidin, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, Syukri, & Halida, 2017) yang berjudul "Peningkatan motivasi anak makan sayuran melalui metode bermain permainan cooking class pada anak usia 4-6 tahun" menemukan bahwa, melalui metode bermain permainan cooking class dapat meningkatkan motivasi anak makan sayuran pada anak usia 4-6 tahun di RA AL- Muhajirin Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Vegetable Eating

Motivation (VEM) merupakan salah satu bentuk permainan yang dirancang oleh peneliti dengan tujuan memberikan motivasi dan edukasi kepada anak prasekolah dengan pendekatan bermain yang dilakukan dalam bentuk rangkaian permainan dan dilakukan selama 6 hari, dengan tujuan untuk

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025 Tahun 2025, disimpulkan sebagai berikut:

1. Di ketahui bahwa dari 30 responden, sebagian besar responden berdasarkan *pre test* Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) dengan frekuensi makan sayur yaitu dalam kategori frekuensi Normal >1x/hari (13,3%) untuk ketegori frekuensi Kurang<1x/hari (53,3%), sangat kurang (33,3%) dan *post test* Penerapan *Vegetable Eating Motivasion (VEM)* Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun yaitu frekuensi Normal >1x/hari (56,7%) dan frekuensi Kurang<1x/hari (36,7%) sangat kurang (6,7%) dengan total (100.0%).
2. uji *statistic* Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh p=0,001 (p<0,05) maka terbukti bahwasannya ada Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun

6.2.1. Bagi responden

Diharapkan kepada ibu yang mempunyai bayi agar bisa menerapkan pemberian vegetabele eating ini kepada anak dengan Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur

6.2.2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bahan ajar khusus bagi mahasiswa studi S1 Kebidanaan dalam hal mempelajari cara mengatasi permasalahan menangani Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur

6.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya meneliti Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025 Tahun 2025dan dengan responden yang relatif sedikit, maka dari itu disarankan agar penelitian lanjutan menggunakan jumlah responden yang lebih besar, serta dapat menambah variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Emulyani, E., & Zahyani, M. (2018). PengaruPh Terapi Bermain Vegetable Eating Motivation (VEM) terhadap Perilaku Makan Sayuran. Jurnal Keperawatan Abdurrab, 1(2), 1-11.

Fitriawati, D. R. (2014). Pola Konsumsi Sayur dan Buah serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi pada Mahasiswi Baru Jurusan Gizi Perantauan di Kota Malang(Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). http://repository.ub.ac.id/id/eprint/124451

Islaeli, I., Novitasari, A., & Wulandari, S. (2020). bermain vegetable eating motivation (VEM) terhadap perilaku makan sayuran pada anak prasekolah. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1), 879-890. 10.31004/obsesi.v5i1.734

Islamiyah, I., Novianti, A. D., & Anhusadar, L. (2024). Pengaruh Terapi Bermain Puzzel untuk Penurunan Kecemasan Hospitalisasi pada Anak Usia Prasekolah. Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1), 87-98. https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.409

Kalmpourtzidou, A., Eilander, A., & Talsma, E. F. (2020). Global vegetable intake and supply compared to recommendations: a systematic review. Nutrients, 12(6), 1558. https://doi.org/10.3390/nu12061558

Karimah, M. (2023). Pengaruh Terapi Bermain Vagetable Eating Motivation (VEM) Terhadap Peningkatan Makan Sayuran Pada Anak Pra-Sekolah Di Tk Sekar Jambi Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten

Pamekasan(Doctoral dissertation, Universitas wiraraja). http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/2853

Nelista, Y., Fembi, P. N., & Elfi, T. (2023). Penerapan Model Peers Modeling Motivation Terhadap Motivasi dan Perilaku Makan Sayur pada Anak Usia Pra Sekolah. Jurnal Kesehatan, 12(1), 99-105. https://doi.org/10.46815/jk.v12i1.121

Prastina, E. D. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Pola Makan Pada Anak Usia Prasekolah Dengan Perkembangan Motorik Kasar Di Tk Desa Teguhan Kec. Jiwan Kab. Madiun(Doctoral dissertation, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun). http://repository.stikes-bhm.ac.id/id/eprint/771

Puastiningsih, S. (2018) Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Model Pembelajaran THINK PAIR SHARE Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Anak Usia Sekolah Dalam Konsumsi Sayur. Skripsi, Fakultas Keperawatan, Program Studi Pendidikan Ners, Universitas Airlangga: Surabaya

Wulansari, A., & Chandra, F. (2019). Pentingnya Konsumsi Sayur dan Buah bagi Anak Sekolah di SDN 082/IV Sijenjang. Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK), 1(2), 123-127. http://dx.doi.org/10.36565/jak.v1i2.37

Yosefina Nelista1, P. N. F. (2021).Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Berbahan Dasar Lokal Terhadap Perubahan Berat Badan Balita Gizi Kurang. 2(September), 1228–1234.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Responden yang terhormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa	: Intan Wulandari
Nomor induk mahasiswa	: 21.22.048
Fakultas	: Sarjana Kebidanan
Program studi	: S1 KEBIDANAN
Alamat	: JL. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang

Dalam kesempatan ini, saya memohon kepada ibu hamil untuk menjadi responden mengenai "Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (Vem) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025".

Penelitian ini ditujukan untuk skripsi program sarjana kebidanan dan juga untuk memberikan masukan kepada ibu tentang Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (Vem) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025.

Saya memohon kepada ibu selaku responden atas ketersediannnya untuk dimintai keterangan dengan lembar observasi dan SOP melalui penelitian yang akan dilakukan kepada responden. Saya juga akan menjaga kerahasiannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Responden

Deli Tua, Mei 2025

Peneliti

( ) (Intan Wulandari)

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN (*INFORMED CONCENT)* BERSEDIA

BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Saya :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Intan Wulandari

Npm : 21.22.048

Pendidikan : Mahasiswa Sarjana Kebidanan Fakultas Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Judul proposal : Pengaruh Penerapan *Vegetable Eating Motivasion* (Vem) Terhadap Prilaku Makan Sayur Pada Anak Stunting Usia 3 Tahun Di Klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025

Saya akan bersedia sebagai objek atau sasaran yang akan diteliti oleh peneliti dengan cara mengikuti perlakuan yang akan diberikan peneliti terhadap saya dengan sukarela demi kepentingan penelitian ini. Demikian surat ini saya tandatangani atas kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Peneliti

Deli Tua, Mei 2025

Responden

(Intan Wulandari)

(_____)

Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI

PENGARUH PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

Lembar Observasi Perilaku Makan Sayur Selama 8 Hari

Hari / anggal	Sayur yang Disajikan	Pag ☐	Sian ☐	Mala m ☐	Total rekuensi	Respons Anak *(✓ salah satu)*	Catatan Tambahan
Hari 1						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	
Hari 2						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	
Hari 3						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	
Hari 4						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	

Hari 5						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	
Hari 6						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	
Hari 7						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	
Hari 8						☐ Menolak ☐ Acuh ☐ Mau Sedikit ☐ Mau Semua	

C. Petunjuk Pengisian:

- ✔ Centang waktu makan saat anak mengonsumsi sayur (pagi/siang/malam).
- □ Total Frekuensi = jumlah waktu makan sayur di hari itu (maksimal 3).
- Respons Anak dipilih salah satu berdasarkan reaksi anak.
- □ Catatan Tambahan bisa diisi jika ada kejadian khusus atau perubahan.

Lampiran 4

LEMBAR KOSIONER

PENGARUH PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN DI KLINIK BERSALIN BIDAN SUMIARIANI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN TAHUN 2025

Identitas Responden

1. Nama Anak: _____
2. Usia Anak: _____ Tahun
3. Jenis Kelamin:
   - ☐ Laki-laki
   - ☐ Perempuan
4. Nama Orang Tua/Wali: _____

Perilaku Makan Sayur Anak

Mohon beri tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan kebiasaan anak Anda.

No	Pernyataan Perilaku Makan Sayur	Selalu (3)	Kadang-kadang (2)	Jarang (1)	Tidak Pernah (0)
1	Anak mau mencoba sayur baru yang diberikan				
2	Anak menghabiskan sayur yang disajikan saat makan				
3	Anak meminta sayur saat makan				

4	Anak menunjukkan minat melihat atau memegang sayur				
5	Anak menikmati makan sayur tanpa paksaan				
6	Anak mengetahui nama beberapa jenis sayur				
7	Anak menyukai warna dan bentuk sayur yang disajikan				
8	Anak terlibat saat membantu menyiapkan sayur (misal mencuci)				

Frekuensi Konsumsi Sayur

1. Berapa kali dalam sehari anak Anda biasanya makan sayur?
    - ☐ Tidak pernah
    - ☐ 1 kali sehari
    - ☐ 2 kali sehari
    - ☐ 3 kali atau lebih
2. Jenis sayur apa yang paling sering dikonsumsi anak Anda?

---

3. Apakah Anda pernah menerapkan cara khusus (misal: cerita, permainan) untuk memotivasi anak makan sayur?
    - ☐ Ya
    - ☐ Tidak

Jika ya, mohon jelaskan:

Persepsi Orang Tua terhadap Perilaku Makan Sayur Anak

1. Apakah Anda merasa anak Anda sudah cukup makan sayur?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

2. Apa kendala utama saat anak makan sayur?

---

3. Apa yang biasanya Anda lakukan agar anak mau makan sayur?

Lampiran 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERAPAN *VEGETABLE EATING MOTIVASION* (VEM) TERHADAP PRILAKU MAKAN SAYUR PADA ANAK STUNTING USIA 3 TAHUN

Pengertian	VEM (Motivasi Makan Sayur) mengacu padaseperangkat prosedur dan pedoman untuk menerapkan pendekatan berbasis permainan untuk meningkatkan konsumsi sayuran pada anak kecil Ini adalah metode yang menggunakan permainan dan aktivitas untuk memotivasi dan mendidik anak-anak tentang manfaat mengonsumsi sayuran, menumbuhkan sikap positif terhadapnya.
Tujuan	untuk mengurangi Jumlah stunting pada anak prasekolah Intervensi gizi spesifik berpokus pada penanganan penyebab langsung stunting, seperti kekurangan asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi.
Frekuensi	makan sayur anak dapat diukur dengan melihat seberapa sering anak mengonsumsi sayur dalam sehari.Setiap kali makan, setengah bagian piring sebaiknya berisi buah dan sayur, dengan lebih banyak sayuran.

Kegiatan dan Materi:	Kegiatan dan materi khusus yang digunakan dalam sesi VEM akan bervariasi tergantung pada usia dan minat anak-anak. Namun, beberapa contoh umum meliputi: • **Permainan Interaktif:** Permainan yang melibatkan menyortir, mencocokkan, atau mengidentifikasi sayuran yang berbeda. • **Bermain Peran:** Skenario di mana anak-anak bertindak seperti sayuran, berbicara tentang manfaatnya. • **Aktivitas Kreatif:** Menggambar, melukis, atau membuat kolase sayuran. • **Bercerita:** Menggunakan cerita tentang sayuran atau pentingnya sayuran dalam diet sehat. • **Eksplorasi Sensorik:** Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyentuh, mencium, dan mencicipi berbagai sayuran. • **Bahan:** Contoh bahan yang mungkin digunakan meliputi: – Gambar atau kartu catatan berbagai sayuran. – Sayuran mainan atau replika sayuran. – Perlengkapan menggambar atau mewarnai. – Buku cerita atau materi pendidikan lainnya.

Langkah-langkah Implementasi	• **Persiapan:** Kumpulkan semua bahan yang diperlukan dan rencanakan kegiatan untuk sesi tersebut. • **Pendahuluan:** Perkenalkan secara singkat topik sayuran dan pentingnya sayuran kepada anak-anak. • **Kegiatan:** Libatkan anak dalam kegiatan yang direncanakan, fasilitasi interaksi dan pembelajaran. • **Pembahasan:** Dorong anak-anak untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka tentang sayuran yang mereka pelajari. • **Penguatan:** Penguatan positif dan pujian dapat mendorong anak untuk terus mencoba sayuran baru.
Hasil yang di harapkan	Meningkatnya kemauan untuk mencoba sayuran baru, Peningkatan pemahaman tentang manfaat memakan sayuran, dan Sikap positif terhadap sayuran.

Lampiran 6

MASTER DATA

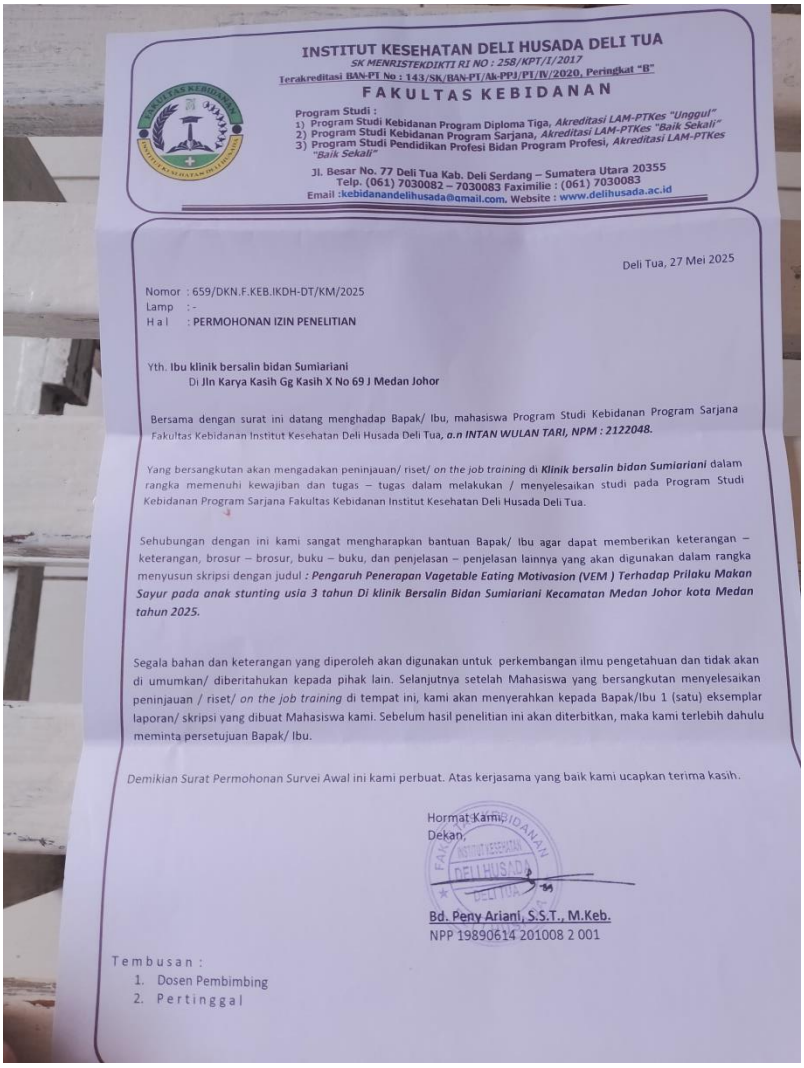
No	Nama Responden	Umur	Jenis Kelamin	Berat Badan (Kg)	frekuensi makan sayur	Frekuensi Makan Sayur		
						Pre Test	Post Test	
1	An.A	1	1	2	1	3	1	
2	An. B	1	1	2	1	3	1	
3	An.B	1	1	2	2	3	1	
4	An.B	1	2	2	1	1	1	
5	An.C	1	1	2	1	3	1	
6	An.E	1	2	2	1	3	1	
7	An.E	1	1	1	2	3	1	
8	An.G	1	2	1	1	1	2	
9	An.H	1	1	1	2	3	2	
10	An.H	1	2	2	3	3	2	
11	An.I	1	1	1	3	2	2	
12	An.J	1	2	2	3	2	2	
13	An.K	1	1	2	1	2	1	
14	An.L	1	2	1	3	3	2	
15	An.M	1	1	1	2	2	1	
16	An.M	1	2	1	2	2	3	
17	An.M	1	1	2	3	3	2	
18	An.N	1	1	2	3	2	1	
19	An.N	1	2	2	2	2	1	
20	An.P	1	1	2	2	2	2	
21	An.Q	1	2	2	2	2	1	
22	An.R	1	1	2	2	1	2	
23	An.S	1	1	2	3	3	1	
24	An.W	1	2	2	2	2	3	
25	An.K	1	1	1	1	2	2	
26	An.O	1	2	1	3	3	1	
27	An.W	1	2	2	2	3	2	
28	An.T	1	2	1	1	2	1	
29	An.P	1	2	1	1	3	1	
30	An.L	1	1	1	1	3	1	

Keterangan:

Umur	Jenis kelamin	Berat Badan	Frekuensi Makan Sayur	
			Pre Test	Post Test
1. 3 Tahun	1. laki laki	1. 8 Kg	1. frekuensi Normal>1x/hari	1. frekuensi Normal >1x/hari
	2. erempuan	2. 9 Kg	2.frekuensi kurang <1x/hari	2.frekuensi Kurang <1x/hari
			3. frekuensi Sangat Kurang	3. frekuensi Sangat Kurang

Lampiran 7

SURAT PENELITIAN



INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
SK MENRISTEKDIKTI RI NO : 258/KPT/I/2017
Terakreditasi BAN-PT No : 143/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020, Peringkat "B"
FAKULTAS KEBIDANAN

Program Studi :
1) Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga, *Akreditasi LAM-PTKes "Unggul"*
2) Program Studi Kebidanan Program Sarjana, *Akreditasi LAM-PTKes "Baik Sekali"*
3) Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, *Akreditasi LAM-PTKes "Baik Sekali"*

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email :kebidanandelihusada@gmail.com, Website : www.delihusada.ac.id

Deli Tua, 27 Mei 2025

Nomor : 659/DKN.F.KEB.IKDH-DT/KM/2025
Lamp : -
H a l : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Yth. **Ibu klinik bersalin bidan Sumiariani**
Di **Jln Karya Kasih Gg Kasih X No 69 J Medan Johor**

Bersama dengan surat ini datang menghadap Bapak/ Ibu, mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, ***a.n INTAN WULAN TARI, NPM : 2122048.***

Yang bersangkutan akan mengadakan peninjauan/ riset/ *on the job training* di ***Klinik bersalin bidan Sumiariani*** dalam rangka memenuhi kewajiban dan tugas – tugas dalam melakukan / menyelesaikan studi pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

Sehubungan dengan ini kami sangat mengharapkan bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan keterangan – keterangan, brosur – brosur, buku – buku, dan penjelasan – penjelasan lainnya yang akan digunakan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul ***: Pengaruh Penerapan Vagetable Eating Motivasion (VEM) Terhadap Prilaku Makan Sayur pada anak stunting usia 3 tahun Di klinik Bersalin Bidan Sumiariani Kecamatan Medan Johor kota Medan tahun 2025.***

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan di umumkan/ diberitahukan kepada pihak lain. Selanjutnya setelah Mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan peninjauan / riset/ *on the job training* di tempat ini, kami akan menyerahkan kepada Bapak/Ibu 1 (satu) eksemplar laporan/ skripsi yang dibuat Mahasiswa kami. Sebelum hasil penelitian ini akan diterbitkan, maka kami terlebih dahulu meminta persetujuan Bapak/ Ibu.

Demikian Surat Permohonan Survei Awal ini kami perbuat. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Dekan,

Bd. Peny Ariani, S.S.T., M.Keb.
NPP 19890614 201008 2 001

Tembusan :
1. Dosen Pembimbing
2. Pertinggal

Lampiran 8

DOKUMENTASI PENELITIAN







Lampiran 9

UJI STATISTIK PENELITIAN

Frequencies

Statistics

		Jenis_Kelamin_	Umur_	Berat_Badan_	Frekuensi_Makan_Sayur_	Pretest	Pos_Test
N	Valid	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1,47	1,00	1,60	1,90	2,20	1,50
Median		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Mode		1	1	2	1[a]	2	1
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		2	1	2	3	3	3

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Jenis_Kelamin_

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	16	53,3	53,3	53,3
	Perempuan	14	46,7	46,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Berat_Badan_

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	12	40,0	40,0	40,0
	9	18	60,0	60,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Frekuensi_Makan_Sayur_

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Frekuensi Normal >1x/hari	11	36,7	36,7	36,7
	Frekuensi kurang <1x/hari	11	36,7	36,7	73,3
	Sangat Kurang	8	26,7	26,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Pretest

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Frekuensi Normal >1x/hari	4	13,3	13,3	13,3
	Frekuensi Kurang <1X/hari	16	53,3	53,3	66,7
	sangat Kurang	10	33,3	33,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Pos_Test

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Frekuensi Normal >1x/hari	17	56,7	56,7	56,7
	Frekuensi Kurang <1x/hari	11	36,7	36,7	93,3
	Sangat Kurang	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jenis_Kelamin_	30	1	2	1,47	,507
Umur_	30	1	1	1,00	,000
Berat_Badan_	30	1	2	1,60	,498
Frekuensi_Makan_Sayur_	30	1	3	1,90	,803
Pretest	30	1	3	2,20	,664
Pos_Test	30	1	3	1,50	,630
Valid N (listwise)	30				

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Pretest	Mean		2,20	,121
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,95	
		Upper Bound	2,45	
	5% Trimmed Mean		2,22	
	Median		2,00	
	Variance		,441	
	Std. Deviation		,664	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		-,242	,427
	Kurtosis		-,634	,833
Pos_Test	Mean		1,50	,115
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,26	
		Upper Bound	1,74	
	5% Trimmed Mean		1,44	
	Median		1,00	
	Variance		,397	
	Std. Deviation		,630	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		1	

	Skewness	,888	,427
	Kurtosis	-,134	,833

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pretest	,285	30	,000	,789	30	,000
Pos_Test	,353	30	,000	,718	30	,000

a. Lilliefors Significance Correction

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pos_Test - Pretest	Negative Ranks	20[a]	13,00	260,00
	Positive Ranks	4[b]	10,00	40,00
	Ties	6[c]		
	Total	30		

a. Pos_Test < Pretest

b. Pos_Test > Pretest

c. Pos_Test = Pretest

Test Statistics[a]

	Pos_Test - Pretest
Z	-3,347[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.